

AfterDoc 医患沟通访谈报告

用于产品范围讨论与黑客松客户发现证据整理

整理日期 2026 年 10 月 3 日 | 工作名称 AfterDoc 小纸条

核心结论

现有材料支持把诊后澄清作为原型的主流程：患者既需要明确下一步，也可能需要了解治疗的一般逻辑、风险和需要向专业人员确认的问题。诊前简述具有探索价值，但其能否节省医生时间仍需验证。

不同患者的困难并不相同。理解不清、担心副作用、忘记执行和生活习惯冲突，应分别识别；增加解释不能自动解决所有执行障碍。

资料来源与统计口径

资料组	访谈人与对象	日期与状态
A	Joanna 家庭材料 父亲及母亲分开整理	日期待确认 由家长在本次对话转述
B	宋悦然 母亲及父亲	10 月 2 日 队员访谈笔记
C	李瑞阳 家人中的患者及护理视角	10 月 2 日 人数与职业身份待确认

目前可区分四位父母的经历，以及一组包含患者与护理视角的家庭材料。不能把同一人的不同视角重复计为多个受访者。是否满足活动期间访谈要求，应按实际访谈日期、人数和记录核对。

报告的使用边界

本报告依据对话转述与简要笔记整理，不是逐字访谈稿。受访者陈述均采用内容归纳，不冒充原话。样本来自家庭便利抽样，不能用于推断中国患者总体比例，也不能证明产品已经改善信任、依从性或临床结局。

报告不记录真实姓名、病历或可识别医疗资料。疾病背景仅保留与产品需求相关的必要信息；对外展示前应获得相关受访者同意。

一 Joanna 家庭访谈

来源：家长在本次对话中分别转述父亲与母亲的经历。正式访谈日期、方式及 Joanna 是否亲自完成访谈尚待确认。

A1 父亲 家庭照护者

负责家人的挂号和陪诊。生病时不清楚应该挂哪个科室；同一科室下多个门诊名称的差异难以判断。网上预约放号时间不明确，热门号难约，有时能预约的日期距离当下不适较远。

补充痛点：希望预约高级职称医生，但号源紧张，同时不清楚目标医生在哪家医院、哪个门诊出诊，以及应该通过哪个官方入口预约。

当前负担：在身体不适时仍需查找科室、出诊地点及号源信息。现有材料没有提供耗时、发生频次或具体查找过程。

产品判断：这些主要属于就医导航与预约痛点。应记录，但不纳入本轮诊后沟通原型；不能把无法及时获得号源表述成 AI 可以解决的供给问题。

A2 母亲 慢性病患者及家庭照护者

回忆就诊时间较短，得到处方后仍希望知道为何选择该药、为何持续使用一定时间、应关注哪些风险，以及检查的目的。说明书不易理解，就诊结束后继续提问也不方便。

会主动使用 AI 和搜索工具查阅信息，并把处方或治疗信息交给 AI 解释。对长期使用药物存在疑虑；如果解释不足，会影响接受和执行治疗的意愿。她看重知情与参与，而不仅是被提醒服药。

另有携带旧检查资料、排队与预约体验、不同医生建议不一致等经历。对过度医疗和医生态度的担心，属于受访者的感受及个案回忆，不据此判定医生动机或方案质量。

对本项目的启示

为希望深入了解的患者提供可选择的解释深度，同时保留统一的必要行动信息。病历可能记录诊断、药物和使用方法，但不一定记录医生针对该患者的全部决策理由。系统必须区分原文理由、一般医学知识与仍需医生确认的个体理由。

母亲关于药物安全和自行调整用药的回忆，反映信息与信任需求。本报告不据此判断药物是否适合长期使用，也不把自行停药视为成功案例。

二 宋悦然家庭访谈

访谈人：宋悦然 | 访谈日期：10 月 2 日 | 对象：母亲、父亲

记录性质：队员提供的摘要笔记，非逐字稿。

B1 母亲

诊后问题：离开医院后再次询问不方便；出现或担心药物副作用时，不知道如何处理。就诊中感到医生忙、交流少，并可能忘记听到的信息。

未执行医嘱的原因包括副作用、对未使用过药物的过敏担忧、检查不方便，以及未把问题看得足够严重。笔记中关于医生打发患者或以盈利为目的的描述，应按个人感受记录。

产品启示：先辨别问题的性质。源于记录的不清楚可以解释；新出现的症状或是否改变治疗需要专业人员判断；检查不方便应记录为现实障碍，而非一律归因于缺乏知识。

B2 父亲

背景：二型糖尿病患者，学历较高。就诊前会把近期问题写在纸上，询问医生该如何处理；对新药物会询问是否适合使用。

会使用 AI 咨询，认可其作为信息来源的作用，但认为它不能给出真正可用于个人决策的建议。就诊后可能到不同医院或搜索资料，核实治疗信息。

未执行计划的原因包括忘记定时服药、生活习惯、身体舒适感和社交需求。笔记也记录了对某些门诊交流少、直接开单的体验。

产品启示：已有的纸质问题清单是值得保留的用户行为。系统可以帮助整理并导出问题，不应取代患者核实信息的权利。忘记、习惯和社交冲突与理解问题不同。

笔记中应与访谈结果分开的内容

不适部位、持续时间、伴随症状、家族史、既往治疗等条目，是拟定的提问清单，不是受访者已回答的事实。

牙痛与其他疾病关联的描述，是团队功能设想，不是本次访谈验证的发现。原型可记录患者报告的症状，不应自动推断其病因或把此例转化为诊断规则。

三 李瑞阳家庭访谈

访谈人：李瑞阳 | 访谈日期：10 月 2 日 | 对象：家人

身份状态：材料说明家人有医生，但正文使用患者与护士视角。需确认实际受访人数、职业及各段内容归属。

以下按笔记视角整理。

C1 患者视角

笔记记录了医嘱不清楚的经历，以及对医生不耐烦、交流不足的感受。专家和普通门诊之间的态度差异属于受访者的观察，不能表述为普遍规律。

C2 护理或医疗工作视角

认为病史采集常耗费较长时间。重要信息包括起病时间、发展过程、伴随症状、中间就诊和治疗过程，以及可能影响判断的药物、接触史和家族史。

指出诊断不能只依赖检查结果；系统查体和重要体征仍不可缺少。笔记所述化验与 CT 属于检查，不能等同于医生的体格检查。诊前简述不能替代任何一项。

对预问诊工具的顾虑包括效率、无法纳入直观查体信息，以及医生对系统输出的信任。关于国内未有通用系统的表述仅是受访者了解范围内的判断。

对诊后工具持积极态度：患者自己理解、记录和追踪医嘱可能减轻本人及家属负担，尤其适用于容易忘记、难理解医嘱且家属不能常陪伴的人。老年患者由此成为待进一步验证的人群，尚不能直接定为唯一目标用户。

关于就诊录音

受访者认为录音可帮助患者复习医嘱，也可能便于医生表达。这是个人意见，不代表所有医生或医院允许录音。实际使用需确认相关人员同意及场所要求。

本轮原型先使用合成就诊文字材料，展示记录与整理流程；不必为完成演示增加真实录音、语音识别或医院接入。

对诊前功能的约束

输出应短、按时间组织、保留患者原意，并由患者审阅。不确定信息明确标出，不生成诊断。后续需要让临床人员比较原始描述与简述，检查信息是否遗漏、是否增加阅读负担。

四 跨访谈发现与产品取舍

发现	材料支持	产品含义
诊后澄清不方便	A2 B1 C1	从医嘱整理与后续问题开始
信息需求及核实行为不同	A2 B2	让用户选择解释深度
未执行的原因不止理解	A2 B1 B2	区分疑虑 忘记 现实障碍
患者已有准备问题的行为	B2	保留可审阅的问题简述
临床人员关心病史及效率	C2 身份待确认	简述不能替代问诊与查体

建议保留的三个原型功能

- 1 诊后行动计划：从合成处方、病历或检查单抽取已记录的用法、时间、检查与复诊信息，并链接来源。简洁、简要解释、详细三档均保留同一组必要信息。
- 2 有边界的延伸问答：明确区分记录中已有的信息、一般医学教育、未记录信息及新的临床决策。需要专业判断的问题整理成可导出的确认清单；紧急顾虑不能只排入下次就诊。
- 3 辅助诊前简述：围绕不适、时间与担忧提问，生成患者审核的短文。此功能是待测试的补充，不扩展为自动分诊或诊断。

值得展示的智能体行动

读取并抽取记录 → 检查缺失或冲突 → 根据偏好选择解释深度 → 按问题性质选择回答或转交 → 保存行动清单并导出待确认问题。演示应实际执行保存、更新与导出，而不只生成聊天回答。

本轮先不纳入

预约抢号、专家跨院出诊查询、跨院病历整合、完整服药提醒、真实录音及多疾病长期管理。它们可以记录为需求，不能因为出现于访谈就全部加入原型。

目前不能宣称的结果

不能宣称提高依从性、减少误诊、改善医院信任或证明个性化有效。现有访谈说明值得测试的需求；原型评估应报告信息保留、问题分流、工具执行和用户理解表现。

五 补充验证与提交用摘要

提交前补齐的记录

Joanna 家庭材料：补实际访谈日期、方式、谁主持及是否得到使用同意。宋悦然材料：确认两个对象及每段经历的归属。李瑞阳材料：确认人数、职业和患者／护理视角是否属于同一人。

不要把三组材料直接写成三位受访者，也不要把赞赏产品等同于使用意愿。正式记录活动期间完成了多少次访谈，并将尚未确认的信息如实标明。

下一轮优先问的五个问题

- 1 请讲最近一次拿到医嘱后仍不清楚的具体问题。你当时怎么处理，最后有没有得到答复？
- 2 哪些信息只要告诉你怎么做就够了？哪些你一定要知道为什么？请给出上次就诊的例子。
- 3 有没有听懂却没执行的事？当时是忘记、担心、不方便，还是有其他原因？
- 4 看这份合成行动计划，你准备怎么执行？哪些地方仍不明确？这用于探索理解，不是考试。
- 5 对医疗工作者：这份患者简述能直接用吗？遗漏了什么？哪些内容应删除才能减少阅读负担？

可用于英文摘要的证据段落

Team interview notes dated October 2 describe difficulty obtaining post-visit clarification, concerns about medication side effects, and barriers including forgetfulness and daily routines. One participant with type 2 diabetes already prepares written questions and independently checks treatment information. A family interview containing patient and nursing perspectives highlights the importance of structured history-taking, while raising concerns about the efficiency and completeness of pre-visit tools. Joanna's family accounts add a need to understand treatment explanations at a chosen depth. These convenience-sample findings motivate prototype testing; they do not establish wider prevalence or product effectiveness. Respondent identities and interview dates will be confirmed before formal reporting.

原型评估记录

先审查三档页面是否保留同一组源文必要信息，再观察测试者用自己的话说明行动。另测提取遗漏、无依据补充、问题分流与保存导出是否成功。展示实际分母、失败例子与限制，不把少量演示测试解释为临床效果。

附录 可复用访谈记录模板

建议每位受访者单独填写一份。先询问真实经历，再展示概念；不要求提供真实处方、身份证明或完整病历。

基本记录

访谈编号 _____ 访谈人 _____ 日期及所在时区 _____

访谈方式 _____ 对象角色 _____ 是否同意匿名使用 _____

最近一次实际经历

最近一次相关就诊是什么情境？离开诊室后需要做什么？

具体哪里不清楚或没有做到？当时如何处理？是否得到解决？

信息偏好与现实障碍

哪些只想知道怎么做？哪些希望知道为什么？

未执行计划的具体原因及已有解决办法

概念反馈

看过合成示例后，最有用和最没有用的部分分别是什么？

仍不明确的信息或担心 _____

访谈人的整理

受访者原话 仅在确有原始记录时填写

观察到的事实 _____

团队推断 _____

尚待核实 _____

下一步验证 _____